

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: PDI21

1. Identificación del Instrumento

Título original	Peters Delusions Inventory-21 (PDI-21)
Título español	Inventario de Experiencias Delirantes de Peters-21
Sigla	PDI-21
Autores originales	Emmanuelle R. Peters, S. A. Joseph y P. A. Garety
Año original	1999
Adaptador español	López-Ilundain, et al. / Fonseca-Pedrero et al.
Año adaptación	2006 / 2011
Formato	Cuestionario de autoinforme con subescalas multidimensionales

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El PDI-21 se basa en el enfoque del continuo psicótico. Permite medir y evaluar cuantitativamente la ideación delirante en población normal y clínica, no solo en presencia/ausencia del síntoma, sino según su convicción, preocupación e inquietud.

3. Características Generales

Objetivo	Medir la prevalencia y dimensiones de la ideación delirante en la comunidad.
Población	Adolescentes y adultos (población general y clínica).
Administración	Autoadministrado (aprox. 10 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 10 minutos.
Corrección	Suma de puntuaciones de la escala de frecuencia y de las tres subescalas (Inquietud, Preocupación, Convicción).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Ideación Delirante (Sí/No)	21 ítems	Explora la presencia o ausencia de ideas de referencia, persecución, grandiosidad, brujería, etc.
Inquietud / Distress	21 sub-ítems (si la respuesta al ítem es Sí)	Evalúa el nivel de malestar asociado a la idea.
Preocupación / Frecuencia cognitiva	21 sub-ítems (si es Sí)	Mide el tiempo dedicado a pensar en la creencia.
Convicción / Certeza	21 sub-ítems (si es Sí)	Mide la certeza subjetiva que tiene de la veracidad de la idea.

5. Sistema de Puntuación

Para cada respuesta afirmativa (Sí), el paciente valora en una escala de 1 a 5 tres parámetros: Inquietud, Preocupación y Convicción. Se suman las puntuaciones globales: Frecuencia (Sí = 1 punto; rango 0-21) y las puntuaciones dimensionales (rango 0-105 para cada una de las 3 subescalas; puntuación total máxima: 336).

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Puntuaciones medias elevadas en población normal pueden indicar rasgos esquizotípicos o propensión a la psicosis, siendo útil para la investigación de la vulnerabilidad mental sin sobrediagnosticar psicopatología clínica severa.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El PDI-21 cuenta con una consistencia interna sobresaliente (Alfa de Cronbach > 0.82 para la escala total) y muestra una excelente validez discriminante entre población general y clínica.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La adaptación española por López-Ilundain et al. (2006) ratificó la consistencia interna, estructura de 7 factores de contenido y su idoneidad para cribado epidemiológico.

9. Aplicaciones Prácticas

Investigación en psicopatología experimental, cribado preventivo escolar de riesgo de psicosis y psiquiatría social.

10. Fortalezas del Instrumento

- Evaluación multidimensional muy detallada (no dicotómica).
- Mide el distress e inquietud subjetiva, clave en la adaptación funcional del sujeto.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- La corrección puede ser laboriosa debido a los reactivos condicionales.

12. Consideraciones Éticas y Legales

No se debe considerar una puntuación elevada como diagnóstico automático de esquizofrenia o trastorno delirante.

13. Síntesis Técnica General

El PDI-21 es la herramienta de autoinforme estándar para investigar la ideación delirante bajo un modelo de continuo en salud mental.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Peters, E. R., et al. (1999). Introducing the PDI (Peters et al. Delusions Inventory). *Schizophrenia Bulletin*, 25(3), 553-576.
- López-Ilundain, J. M., et al. (2006). Versión española del PDI-21. *Actas Esp Psiquiatr*, 34(2), 94-104.